Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo

Rua General Neto, 486 - Bairro: Centro - CEP: 99010022 - Fone: (54) 3311-5377 - Balcão virtual: (54) 999426870 - Email: frpasfundo3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002725-12.2024.8.21.0021/RS

AUTOR: ELISANDRA PEREIRA DA SILVA CAVALHEIRO
AUTOR: MANUELA DA SILVA CAVALHEIRO
RÉU: UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

MANUELA DA SILVA CAVALHEIRO ajuizou a presente Ação Ordinária em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, ambas qualificadas nos autos, aduzindo que tem oito anos de idade e foi diagnosticada com Diabete Mellitus Insulino-dependente Tipo 1 (CID E10), sendo solicitado pelo médico assistente o uso do equipamento "sensor para medir glicose (freestyle libre/enlite), no total de dois kits por mês de uso, para tratamento contínuo. Afirmou que não existe substituições no mercado para o equipamento. Contou que, apesar da disponibilização de fitas reagentes e glicosímetro na rede pública, não é possível utilizar desses métodos pela dificuldade de aferição da glicemia em criança, considerando a necessidade de três picadas por dia. Disse possuir contrato de assistência à saúde com a demandada, requerendo a cobertura do tratamento indicado, tendo, contudo, negada a cobertura, sob o argumento de que não esta previsto no rol da ANS, além de exclusão de cobertura para assistência domiciliar. Pediu pela aplicação do CDC ao caso concreto. Discorreu acerca do direito à saúde. Postulou pela concessão da tutela de urgência para determinar o custeio dos equipamentos destinados ao tratamento da requerida. Ao final, requereu a procedência da ação, tornando definitiva a tutela requerida. Pediu a gratuidade de justiça e juntou documentos (evento 1, INIC1).

Deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência pleiteada (evento 3, DESPADEC1).

A autora interpôs agravo de instrumento (evento 9), não provido (evento 29).

Citada (evento 8, AR1), a ré apresentou contestação (evento 13, CONT1). Afirmou que exclusão contratual de cobertura para fornecimento do insumo pleiteado. Aduziu que as despesas de *home care* não possuem previsão no rol da ANS, além de que o equipamento pleiteado não consta no respectivo rol de coberturas obrigatórias, de modo que a negativa da ré foi lícita, pois amparada nas disposições do contrato, bem como nas disposições da ANS. Defendeu a licituda de negativa para a cobertura do tratamento requerido. Requereu a improcedência da ação e juntou documentos.

Houve réplica (evento 20, RÉPLICA1).

Afastada a preliminar arguida e instadas as partes acerca do interesse na dilação probatória (evento 21, ATOORD1), ambas requereram o julgamento antecipado da lide (evento 26, PET1 e evento 27, PET1).

Intimado (evento 42, DESPADEC1), o Ministério Público ofertou parecer (evento 45, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Na ausência de questões preliminares pendentes, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação em que pretende a parte autora obrigar a requerida ao custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente, consubstanciado no fornecimento de sensor para medição de glicose (freestyle libre/enlite), tendo em vista a negativa de cobertura do referido tratamento pelo plano de saúde demandado.

A ré, por seu turno, defendeu a licitude da negativa para cobertura do tratamento, tendo em vista a ausência de cobertura contratual, considerando que se trata de equipamento para uso domiciliar, além de não constar no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Cumpre referir que a relação posta nos autos é tipicamente de consumo, do que decorre a incidência das regras previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ:

"*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*".

Dito isso, tem-se que a controvérsia diz respeito com a ausência de obrigatoriedade da ré em custear o tratamento relacionado à equipamento destinado ao uso domiciliar pela requerente, pois expressamente excluído da cobertura contratual avençada entre as partes, bem como pelo fato de não estar previsto no rol da ANS.

De fato, o contrato de assistência à saúde firmado pelas partes em 01/12/2015, prevê a exclusão de cobertura para os procedimentos destinados ao uso no ambiente domiciliar (cláusula 35, XXVIII – evento 13, CONTR2, p. 21).

Nesse ponto, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que "*é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde*" (AgInt no REsp 1.890.823/SP, 4ª Turma, DJe 28/4/2022).

Isso ocorre quando o insumo para tratamento não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Trata-se, pois, de medicamento que pode ser adquirido pelo paciente para ser autoadministrado em seu ambiente domiciliar, sendo esse o caso dos autos.

Assim, a exclusão estabelecida pela operadora do plano de saúde não se revela abusiva, porquanto em harmonia com o entendimento acima colacionado, interpretado pelo respectivo relator à luz da Lei nº 9.656/98.

De outro lado, cumpre referir que o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, tese a respeito do tema, ao julgar o EREsp nº 1886929 e EREsp nº 1889704, nos seguintes termos:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Posteriormente, sobreveio a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei dos Planos de Saúde, nº 9.656/98, em seu art. 10, incluindo o § 12, que prevê o caráter exemplificativo do rol da ANS:

Art. 10. (...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, em que pese a submissão dos planos de saúde às coberturas previstas pelo rol da ANS, a novação legislativa permite que as circunstância do caso concreto caracterizem excepcionalidade, quando comprovada a essencialidade do procedimento para a recuperação do quadro apresentado pelo paciente, considerando a validação técnica à luz de evidências científicas.

No caso dos autos, observa-se que o procedimento indicado pelo médico assistente visa atender as necessidades especiais da autora, permitindo a melhora do seu estado de saúde.

Contudo, o laudo médico constante nos autos, é conclusivo ao afirmar a existência de tratamento alternativo igualmente efetivo para o caso apresentado, afastando, por conseguinte, a situação de excepcionalidade necessária para autorizar o deferimento da cobertura pleiteada.

Especificamente quanto ao laudo apresentado pela requerente, o assistente médico assim afirmou (evento 1, LAUDO10):

Existem medicamentos (alimentação ou insumos) da rede pública de saúde que podem substituir os acima prescritos?

(X) SIM ( ) NÃO

É necessário nominá-los:

- TIRAS REAGENTES E LANCETAS
- GLICOSÍMETRO

Portanto, ainda que exista recomendação médica para o tratamento, consistente na utilização do equipamento requerido, inexiste comprovação de situação excepcional no sentido de corroborar com a imprescindibilidade do meio alternativo para a melhora no quadro de saúde apresentado, tornando inócua a alegação de abusividade na negativa de cobertura apresentada pela requerida.

Por guardarem semelhança com o caso concreto, transcrevo as seguintes ementas do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. *DIABETES* MELITTUS. **FORNECIMENTO DE *SENSOR* PARA CONTROLE CONTÍNUO DA GLICOSE (*FREESTYLE* LIBRE).** TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida, no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento. Caso em que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, comportando a lide julgamento antecipado. Preliminar afastada. Mérito. **No presente caso, a parte autora foi diagnosticada com *Diabetes* Mellitus (CID E10), necessitando de tratamento com insumo de uso domicilar, qual seja, o *sensor* para controle contínuo de glicose *Freestyle* Libre. Todavia, em se tratando de dispositivo de uso domiciliar, não há como se exigir cobertura contratual, tampouco legal, vide art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465/2021.** Ademais, não estando o fornecimento do referido *sensor* previsto no rol da ANS, necessária a demonstração da eficácia do tratamento, nos termos do art. 10, § 13 da Lei 9.565/98, alterado pela Lei nº 14.454/2022, o que restou ausente nos presentes autos. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 50111197520238210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-08-2024) - grifei.

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. *DIABETES* MELLITUS TIPO 1. *SENSOR FREESTYLE* LIBRE.** MONITORAMENTO DE GLICOSE. **TRATAMENTO *DOMICILIAR*. COBERTURA NÃO DEVIDA.** ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50350464120218210010, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 17-04-2024) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ***DIABETES* MELITTUS. FORNECIMENTO DE *SENSOR* PARA CONTROLE CONTÍNUO DA GLICOSE (*FREESTYLE* LIBRE). TRATAMENTO *DOMICILIAR*. RECUSA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.** No presente caso, a parte autora foi diagnosticada com *Diabetes* Mellitus (CID E10), necessitando de tratamento com insumo de uso domicilar, qual seja, o *sensor* para controle contínuo de glicose *Freestyle* Libre. Todavia, em se tratando de dispositivo de uso *domiciliar*, não há como se exigir cobertura contratual, tampouco legal, vide art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465/2021. Ademais, não estando o fornecimento do referido *sensor* previsto no rol da ANS, necessária a demonstração da eficácia do tratamento, nos termos do art. 10, § 13 da Lei 9.565/98, alterado pela Lei nº 14.454/2022, o que restou ausente nos presentes autos. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50195680520228210027, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 21-03-2024) - grifei.

Logo, na ausência de cobertura contratual para o fornecimento do equipamento, aliado à exclusão do tratamento pelo rol da ANS, torna-se licita a negativa apresentada pelo plano de saúde a fim de restringir a cobertura do método prescrito pelo médico assistente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão formulada por **MANUELA DA SILVA CAVALHEIRO** em desfavor de **UNIMED PLANALTO MEDIO/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, nos termos da fundamentação.

Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a natureza da ação, tempo de tramitação processual e trabalho exigido daquele profissional, observadas as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a contar da presente decisão.

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à parte autora, por litigar sob o abrigo da gratuidade judiciária.

Intimem-se.

Considerando que o Código de Processo Civil de 2015 suprimiu o juízo de admissibilidade dos recursos realizado pelo primeiro grau, sem necessidade de nova conclusão, exceto na hipótese de embargos de declaração, em sendo interposta apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias (§ 1º do art. 1.010 do CPC).

Na hipótese de sobrevir apelação adesiva no mesmo lapso, intime-se o recorrido adesivo para apresentar contrarrazões em 15 dias (§ 2º do art. 1.010 do CPC).

Cumpridas as diligências legais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido e tomadas eventuais providências quanto às custas, baixem-se e arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **JULIANA PASETTI BORGES, Juíza de Direito**, em 11/11/2024, às 16:20:7, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10071636856v36** e o código CRC **6ce77d3c**.